



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : سماح فاروق سعدالدين محمد

المحافظة : الجيزة الحي / المدينة : الجيزة

العنوان : 6 ح مرزوق ش المحطة الجيزة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 30-09-2026

رقم البطاقة : 27807112101864 رقم التليفون : 01103804621

العمر (تاريخ الميلاد) : 11-07-1978 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك الإحصائي الاجتماعي التوقيع: (-----) المقر بما فيه التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام ماموجرام وسونار علي الثديين [10888] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني الوظيفة: التوقيع: (-----)
الاسم: د/ندى حسن الوظيفة: التوقيع: (-----)
الاسم: د/نرمين رمضان الوظيفة: التوقيع: (-----)
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة. تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
جهة العلاج :
ملاحظات :
قسم :
نفقات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: سماح فاروق سعدالدين محمد National ID: 27807112101864	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Bilateral mammogram and breast ultrasound
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

سماح
فاروق سعد الدين محمد اسعد
أح مرزوق - من المحطة
الجيزة - الجيزة

٢٧٨٠٧١١٢١٠١٨٦٤

IT9307550

~~١١٠٣٨٠٤٦٥١~~
١١٠٣٨٠٤٦٥١



٢٠٢١/٠٢ ٢٧٨٠٧١١٢١٠١٨٦٤
حاصله على دبلوم تجارة

انثى مسلمة



١ البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/٠٢/٢٣





Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



MDT form

A-Patient ID:

1- Name : سماح فاروق سعد الدين محمد

Sex:

3- Medical number:

Female

83263760

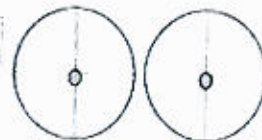
Old Med :

Old Med :

682-2025

2-ID number: 27807112101864

Patient Age : 47-Y



Family history

Family history

Phone

Phone

BMI

BMI

REASON OF MDT

REASON OF MDT

marital status

Marital Status

NRS Score

NRS Score

GROUP

GROUP

Date of MDT

Date of MDT

Co morbidity

Co Morbidity
dm

Menopausal
status

Menopausal Status
PREMENOPAUSAL

Initial STAGE

Initial STAGE

2025-05-21



Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :

BX
IDC

ER
7/8

PR
8/8

Her 2 Neu
0

SISH

Ki67
15

Bx COMMENT
It gli

ER COMMENT

PR COMMENT

Her 2 Neu COMMENT

SISH COMMENT

T
4b

N
2

M
0

Sonomammography

PATIENT HISTORY

It breast cancer , solid mass 1.6x1.2 , 3 axillary LN , largest 1.4x1.2 cm

ct cap: free of metastatic (liver , lung)

few vertebral , sternal area reaching 7 mm at DIV, It sacral sclerotic foci mostly bone island

pt on AI+zoladex

BONE SCAN FREE

MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN

For NACT: 4AC + TXI with Zoladex followed by MRM

For NACT: 4AC - 4TXI - Zoladex followed by MRM

MEDICAL ONCOLOGY

MEDICAL ONCOLOGY

RADIOLOGY

RADIOLOGY

SURGERY

SURGERY

PATHOLOGY

PATHOLOGY

Psychiatric

Psychiatric

Nutrition

Nutrition

Patient Name : الأستاذ / سماح فاروق محمد الدين محمد	Request No. : 13003523
Patient No. : 27807112101864	Request Date : 13/01/2025
Path No. : 147/25	Verification Date : 17/02/2025
Sex : Female	Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Age : 46 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical data:

Left breast mass.

Specimen of specimen:

Tru cut biopsy, collected at 12/1/2025 , 11:45 am.

Gross examination

Four greyish white tissue cores up to 1 cm , totally submitted.

Technique:

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter stain. The sections treated against:

-ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5). & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:

Histological type: Invasive duct carcinoma .

Grade (differentiation +nuclear pleomorphism+mitosis): (3+2+1) Grade II .

DCIS: Could not be detected within the limits of biopsy recieved.

Angioinvasion: Could not be detected within the limits of biopsy recieved.

IPT (Positive control showed appropriate reactivity):

ER: Moderate nuclear reaction in 80% of tumor cells (score 7/8).

PR: Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (score 8/8).

Her2: No membrane reaction in tumor cells (score 0).

Ki67: 15% nuclear reaction of tumor cells.

Diagnosis:

Left breast mass, tru cut biopsy:

Invasive duct carcinoma, Grade II .

Verified by :

dr.esraa magdy

Patient Name	: الأستاذ / سماح فاروق سعد الدين محمد	Request No.	: 13003523
Patient No.	: 27807112101864	Request Date	: 13/01/2025
Ref No.	: 147/25	Verification Date	: 17/02/2025
Sex	: Female	Financial Category	: أورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 46 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc	:	Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

ER: Positive (score 7/8).

PR: Positive (score 8/8).

Her2: Negative (score 0).

Ki67: Positive in 15% of tumor cells.

Scoring system: "ER, PR"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013. IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within < 10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is incomplete, intense < 10% of tumor cells.

Dr. Rana Fathy

Dr. Menna Nabil

Verified by :

dr.esraa magdy



Patient Name: Samah Farouk Saad Al Din Mohamed	Date : 02/03/2025
Exam : C.T CHEST	Age : 37 Year(s)
Medical ID: 682/2025	Pat. ID: 98151

NON CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Findings:

I Chest:-

- Left breast UOQ area of parenchymal distortion.
- Multiple left axillary level I & II pathologically enlarged lymph nodes largest measuring 1.6 x 1 cm.
- Right upper and left lower lung lobe calcified nodules likely old granuloma.
- No other sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Right thyroid hypodense nodule measuring 5 mm.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is of average size with homogenous CT texture. No definite enhancing focal lesions or contour irregularities.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Bulky uterus.



Patient Name: Samah Farouk Saad Al Din Mohamed	Date : 02/03/2025
Exam : C.T CHEST	Age : 37 Year(s)
Medical ID: 682/2025	Pat. ID: 98151

- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

***Scanned skeleton:**

- Few lucent vertebral and sternal areas reaching 7 mm at D1 vertebral body.
- L5, D3 & C7 lytic lesions with vertical striation likely hemangiomas.
- Left scapula sclerotic foci mostly bone islands.

Opinion:

- Left breast UOQ area of parenchymal distortion.
- Multiple left axillary level I & II pathologically enlarged lymph nodes.
- No evidence of pulmonary or hepatic metastatic deposits on non-contrast basis.
- Few osseous lesions for bone scan.

Dr. Ali Saber, MSc.

Dr. Mohamed Mohsen, M.D.



Exam Information:

<u>Patient Name:</u> Samah Farok	<u>Date of birth:</u> 11/07/1978
<u>Arabic Name:</u> سماح فاروق	<u>Patient Gender:</u> F
<u>Patient RIS ID:</u> 368714	<u>Exam Date:</u> 27/04/2025
<u>Patient HIS ID:</u> 10110225007161	
<u>Written by:</u> Dr. Hoda Fathy	<u>Approved by:</u> Dr. Hoda Fathy

^{99m}Tc MDP Bone Scan Report (27/4/2025)

* Whole Body Anterior and Posterior Planar Views Acquired 2Hrs. Post I.V Injection of 20mCi of ^{99m}Tc MDP
Revealed:

- No definite evidence of active osseous deposits could be seen over the surveyed skeleton.
- Degenerative changes are noted over the dorso-lumbar vertebrae.
- Arthritic changes are noted over both shoulder and both knee joints.
- Both kidneys are visualized.

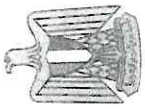
Conclusion:

- No definite evidence of active metastatic osseous deposits could be seen all over the surveyed skeleton.

Much Obligated

Mahmoud Akram

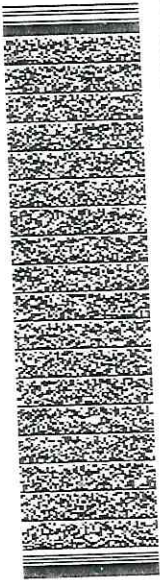
Randa Ali, MSc



٢٠٢١/٠٢ ٢٧٨٠٧١١٢١٠١٨٦٤
حاصله على دبلوم تجاره

أنثى
مسلمة

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/٠٢/٢٢



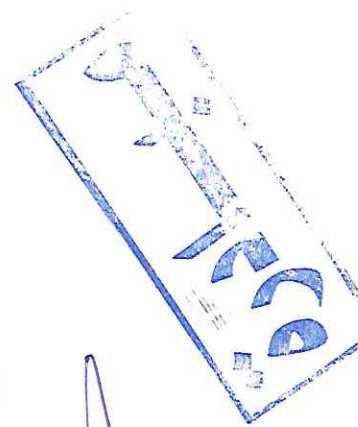
٤٦

٤٦

١٨٦٤٠٧١١٢١٠٢٧٨

٤٦

٤٦



مملكة فلسطين
بطاقة تحقق الشخصية

سماح
فاروق سعد الدين محمد اسعد
٦٠٢١ - ٢٧٨٠٧١١٢١٠١٨٦٤
الجيزة - الجيزة



٢٧٨٠٧١١٢١٠١٨٦٤

IT9307550

MDT FORM

21/12/2025 G

Name	الح فاروق عبد الله	MRN	682-2025
		ID	27807112101864
Age	Premen	Phone	01103804621
Menopausal status	48 Cter induced	Marital status	Married xx children
NRS SCORE	Amnesher	Family history	
BMI		REASON OF MDT	Surgical Review
CO morbidity	DM → poorly controlled, on oral hypoglycemic		

Clinical Data

BX: Left Br IDC GII

R

L

ER:

7/18

PR:

8/18

HER 2:

0

Ki67:

Sonomammography: ACR B

Left Br Ca, paraf-aerian 1cm Retro at 11 o'clock 16x12

Mets Workup:

+ enlarged 3 ax. LNs w/ effaced hilum 14x12 — BIRADS 5 TNM 4B 2 0

CT CAP → left ax. level I & II LNs

→ No pulmonary or hepatic mets

Recommendations:

→ few osseous lesion → prever-use on Bone free scan
→ Pt received NACT 4x AC & 4x TXT, last on 3/12/2025

for surgical and regularity in keta
For Left MRM (as planned) 3/12/2025

MDT OUTCOME & PLAN

for Lt MRM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY

SURGERY

RADIOLOGY

PATHOLOGY

Nutrition

Psychiatric

[Signature]

[Signature]

ECHO REPORT

NAME: ساح فاروق عبد DATE: 5 / 1 / 2026
ID NUMBER: 7nc / c.co SEX: F AGE: 47

The patient is Tachycardic

EF	<u>69.1</u>	55-75%	PWT	<u>0.7</u>	0.6-1.1cm
LVEDD	<u>4.1</u>	3.5-5.8cm	AO.R	<u>2.3</u>	3-3.7cm
LVESD		2-4cm	LA	<u>3.3</u>	2-4cm
FS		25-45%	RV		0.7-2.3cm(supine)
SWT	<u>0.8</u>	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

LV Dimensions *simcl*

LV Wall Thickness *simcl*

LV Diastolic Function *simcl*

SWMA *0 SWT TR*

LA and Ao Root Dimensions *simcl*

Mitral Valve *Trivial TR*

Aortic Valve *simcl*

Tricuspid Valve *Tild TR*

Pulmonary Valve *simcl*

Right Side and Systolic Function *simcl*

Intracardiac Masses and Effusion *simcl*

DR.

Signature